NEXO INTELIGÊNCIA CLÍNICA / LEITURAS PARA CONECTAR IDEIAS

Psicologia em Pauta

EDIÇÃO 03

PROFISSÃO, CIÊNCIA E SOCIEDADE

Você sabe mesmo o que um psicólogo faz?

Ciência, avaliação, responsabilidades profissionais e trabalho em rede

Texto e curadoria de
Gabriel Alves Batista



O encontro humano faz parte de um campo amplo de conhecimento. Acervo editorial próprio · imagem ilustrativa

Edição digital em A4 • Texto selecionável • Referências e links

Uma leitura educativa para ampliar perguntas e possibilidades.

GUIA DA EDIÇÃO

Entre ideias, histórias e perguntas.

Dossiê educativo sobre Psicologia, Neuropsicologia, diagnóstico, psicofármacos, SUS, SUAS e colaboração entre profissões.

Por que esta edição existe . . . 3
Como a Psicologia produz conhecimento . . . 4
Corpo, história e contexto na mesma investigação . . . 5
Uma pessoa, quatro lentes profissionais . . . 6
Diagnóstico, hipóteses e Neuropsicologia . . . 7
Compreender, colaborar e respeitar os limites de prescrição . . . 8
Psicologia, SUS, SUAS e trabalho em rede . . . 9
O trabalho que sustenta a sessão . . . 10
Perguntas para revisar seu mapa das profissões . . . 11
O que vem pela frente . . . 12
Referências da edição. . . . 14

Continuar a leitura no navegador

A leitura e os exercícios têm finalidade educativa. Exemplos e perguntas ajudam a observar contextos e não substituem avaliação individual.

CAPÍTULO 01

Por que esta edição existe

Um dossiê para quem cuida, para quem trabalha em rede e para quem só quer entender melhor onde buscar ajuda.

Este editorial nasce de uma pergunta simples: quanto a população realmente sabe sobre Psicologia? Não se trata de disputar espaço com Medicina ou Serviço Social. Trata-se de tornar visível o que cada profissão acrescenta e como elas podem trabalhar juntas sem apagar suas diferenças.

Quando Psicologia vira apenas “escuta”, perde-se de vista um campo científico que estuda comportamento, cognição, desenvolvimento, aprendizagem, relações, saúde, trabalho e muito mais.

A saúde mental ganhou espaço público, mas a compreensão sobre quem faz o quê não cresceu na mesma velocidade. O resultado é um paciente que circula entre profissionais e, muitas vezes, precisa traduzir sozinho o próprio cuidado.

A Psicologia brasileira é uma profissão relativamente jovem, regulamentada em 1962. Desde então, ampliou-se da clínica para escolas, hospitais, organizações, justiça, assistência social, atenção básica, neuropsicologia, reabilitação e pesquisa. A imagem pública, porém, ainda costuma caber num divã.

Se a sua definição de Psicologia cabe apenas na palavra escuta, talvez este dossiê mostre o tamanho do pedaço que ficou de fora.

Gabriel Batista - texto da edição original

CAPÍTULO 02

Como a Psicologia produz conhecimento

A Psicologia mantém um diálogo histórico com a Filosofia e produz conhecimento por métodos científicos próprios. Formula hipóteses, produz medidas, compara grupos, acompanha trajetórias, testa relações, constrói instrumentos e revisa modelos conforme os dados.

Se a Psicologia não prevê tudo, então não é ciência?

Gabriel Batista - texto da edição original

Não. Ciência não exige adivinhação perfeita. Epidemiologia, medicina, economia e meteorologia também trabalham com incerteza. Em Psicologia, muitas previsões são probabilísticas: diante de determinadas condições, certos comportamentos tornam-se mais ou menos prováveis.

- experimentos e estudos observacionais
- psicometria e testes padronizados
- estatística e modelos probabilísticos
- medidas psicofisiológicas e neurociência
- métodos qualitativos e análise contextual

As diretrizes curriculares atuais exigem formação fundamentada em conhecimento científico e compreensão da complexidade do fenômeno psicológico.

CAPÍTULO 03

Corpo, história e contexto na mesma investigação

Antes de chamar de depressão, você olhou para o resto da pessoa?

Gabriel Batista - texto da edição original

Sintomas psicológicos não chegam etiquetados com a origem. Corpo, história, medicamentos, sono, ambiente, trabalho e relações podem participar do mesmo quadro.

O modelo biopsicossocial não é um condomínio em que o médico recebe o “bio”, o psicólogo o “psico” e o assistente social o “social”. Cada profissional precisa enxergar a pessoa inteira, ainda que responda por métodos e responsabilidades diferentes.

> Caso ilustrativo: “Estou cansado, sem concentração, sem desejo sexual e não consigo trabalhar. É depressão?”

Pode haver sofrimento depressivo. Também pode haver efeitos de medicamento, alterações do sono, condições clínicas, sobrecarga laboral, uso de substâncias ou outras variáveis. O ponto não é pedir uma bateria de exames para todo mundo. É reconhecer sinais que tornam uma avaliação médica clinicamente indicada.

Perspectiva	Contribuição descrita no original
Psicologia	Funcionamento psicológico, comportamento, história e contexto.
Medicina	Condições clínicas, exame médico, investigação orgânica e tratamento.
Serviço Social	Direitos, território, proteção social e condições concretas de vida.

CAPÍTULO 04

Uma pessoa, quatro lentes profissionais

As profissões se encontram, mas não são intercambiáveis. O objetivo desta página não é erguer muros; é deixar as portas identificadas.

Profissão	Atuação apresentada no dossiê
Psicólogo	Avalia e intervém sobre processos psicológicos e comportamento. Pode atuar em clínica, saúde, educação, trabalho, justiça, políticas públicas, pesquisa e outros campos.
Neuropsicólogo	Na Psicologia, a Neuropsicologia investiga relações entre cognição, comportamento e funcionalidade por avaliação e intervenção. É uma especialidade reconhecida pelo CFP. O registro de especialista reconhece uma qualificação; segundo o CFP, não é condição obrigatória para o exercício profissional, que exige competência técnica para a atividade.
Psiquiatra	É médico com formação especializada em Psiquiatria. Realiza avaliação médica em saúde mental e pode conduzir investigação clínica e tratamento medicamentoso quando indicado. O cuidado pode envolver outras intervenções e trabalho em equipe.
Assistente social	Atua sobre direitos, políticas sociais, condições concretas de vida, proteção social, acesso a serviços e estudos sociais/socioeconômicos.

Interdisciplinaridade não é todo mundo fazer a mesma coisa. É saber onde seu trabalho encontra o do outro.

Gabriel Batista - texto da edição original

CAPÍTULO 05

Diagnóstico, hipóteses e Neuropsicologia

Se o psiquiatra falou, acabou?

Gabriel Batista - texto da edição original

Não. Uma hipótese diagnóstica pode ser revisada. O valor do diagnóstico está na qualidade das evidências, no raciocínio diferencial e na evolução do caso, não apenas no título de quem o formulou.

O psicólogo realiza diagnóstico psicológico dentro de suas competências e pode integrar classificações diagnósticas quando isso for tecnicamente pertinente. O psiquiatra realiza diagnóstico no âmbito médico, podendo investigar condições orgânicas e prescrever. Nenhum dos dois transforma uma primeira conversa em verdade imutável.

Um teste não fecha um diagnóstico.

Avaliação neuropsicológica integra entrevista, história, observação, dados funcionais, instrumentos padronizados e análise do contexto. Atenção, memória, linguagem ou funções executivas são partes de um perfil, não etiquetas isoladas.

Dificuldades de atenção, alterações do humor ou conflitos nas relações precisam ser compreendidos ao longo do tempo e em seu contexto. Um comportamento isolado não permite ao leitor concluir um diagnóstico. Em situações complexas, o profissional integra história, funcionamento cotidiano e outras fontes pertinentes.

CAPÍTULO 06

Compreender, colaborar e respeitar os limites de prescrição

Se o psicólogo não prescreve, por que deveria entender psicofármaco?

Gabriel Batista - texto da edição original

Alguns medicamentos podem produzir efeitos no cotidiano, inclusive sobre sono, apetite e vida sexual. A ocorrência e a intensidade dependem do medicamento e da pessoa. Na Psicologia, esse relato pode ser acolhido e registrado para favorecer o diálogo com o profissional prescritor; não é uma orientação para alterar o tratamento por conta própria.

Ação	O que a edição diferencia
Compreender	Efeitos percebidos, adesão, impacto psicológico e sinais de alerta.
Colaborar	Registrar, encaminhar e conversar com o prescritor quando houver consentimento e necessidade.
Prescrever	Selecionar medicamento, dose e mudanças do tratamento exige habilitação legal específica. No atendimento psicológico aqui descrito, essas decisões são encaminhadas ao profissional prescritor.

Nos Estados Unidos, o Novo México oferece um exemplo delimitado: o conselho estadual prevê certificados próprios para psicólogos com autorização de prescrição, incluindo etapa supervisionada e revisão dos registros antes da autorização plena. As exigências pertencem àquela jurisdição; não autorizam prescrição por psicólogos no Brasil.

Entender não é prescrever. Mas não entender também pode empobrecer o cuidado.

Gabriel Batista - texto da edição original

CAPÍTULO 07

Psicologia, SUS, SUAS e trabalho em rede

Quando a política é social, o psicólogo vira assistente social?

Gabriel Batista - texto da edição original

Não. Estar no mesmo equipamento não apaga formação, método e atribuições. Há atividades compartilháveis e núcleos profissionais diferentes.

- Acolhimento.
- Trabalho em equipe.
- Articulação de rede.
- Planejamento.
- Discussão de casos.
- Defesa do acesso a direitos e cuidado.

Perspectiva	Contribuição descrita
Psicologia	Processos psicológicos, vínculos, comportamento, desenvolvimento, sofrimento, grupos e funcionamento psicológico.
Serviço Social	Direitos, políticas sociais, benefícios, proteção social, condições concretas de vida, estudos sociais e socioeconômicos.

Rede de cuidado precisa de comunicação responsável, consentimento e contrarreferência quando pertinente. A pessoa não deveria ser obrigada a traduzir sozinha cada pedaço do caso.

Quando uma profissão é usada para tapar o buraco da outra, isso não é interdisciplinaridade. É precarização.

Gabriel Batista - texto da edição original

CAPÍTULO 08

O trabalho que sustenta a sessão



O trabalho também acontece na preparação e no diálogo. Acervo editorial próprio · imagem ilustrativa

O paciente vê a sessão. Nem sempre vê o trabalho que sustenta a sessão.

Gabriel Batista - texto da edição original

Correção de instrumentos, integração de dados, registro, elaboração de documentos, consulta à literatura, planejamento e comunicação em rede também consomem tempo técnico.

- Atendimento - o exemplo visual do original usa 50 minutos.
- Registro e organização.
- Correção e análise.
- Integração e hipótese.
- Documentação e devolutiva.

A jornada não é apenas um debate corporativo. Ela conversa com qualidade do trabalho, produção documental, desgaste emocional e tempo técnico invisível.

Na consulta de 17 de outubro de 2026, a ficha do Senado registra o PL 1.214/2019 em tramitação, aguardando despacho. A proposta de até 30 horas semanais não deve ser apresentada como um direito nacional criado por esse projeto.

CAPÍTULO 09

Perguntas para revisar seu mapa das profissões

Quanto do seu conceito de Psicologia ainda vem do senso comum? Marque a alternativa que melhor representa sua resposta. O objetivo não é “dar nota” em ninguém. É descobrir quais fronteiras profissionais você ainda pode querer pesquisar.

Leia cada situação como um convite à pesquisa e ao diálogo. Não há placar ou classificação do visitante.

- 1. Se um paciente relata queda de libido após iniciar antidepressivo, o psicólogo deve: A) ignorar porque é assunto médico; B) investigar impacto e encaminhar ao prescritor quando necessário; C) orientar redução da dose.

- 2. Uma avaliação psicológica usa testes. Então o diagnóstico vem do teste? A) Sim; B) Não. O instrumento é uma fonte integrada a outras informações.

- 3. No SUAS, psicólogo e assistente social podem executar qualquer função um do outro? A) Sim, porque ambos são equipe técnica; B) Não. Há ações comuns e competências próprias.

- 4. Encaminhar à UBS significa que o psicólogo “não deu conta”? A) Sim; B) Não. Pode significar que reconheceu uma hipótese que exige outra avaliação.

- 5. Quem pode ser a primeira porta de entrada para sofrimento mental? A) Só o psiquiatra; B) Só o psicólogo; C) Depende do caso: Psicologia, Medicina/APS ou outros pontos da rede podem iniciar o cuidado.

- 6. Um neuropsicólogo encontra prejuízo importante de memória. Isso sozinho fecha um diagnóstico? A) Sim; B) Não. É preciso integrar história, funcionalidade, outros dados e, quando indicado, avaliação médica.

- 7. Psicólogo precisa saber alguma coisa sobre psicofármacos? A) Não, porque não prescreve; B) Sim, para compreender efeitos psicológicos/comportamentais e trabalhar em rede sem ultrapassar seu escopo.

- 8. “Biopsicossocial” significa dividir a pessoa entre três profissões? A) Sim; B) Não. Cada profissão precisa considerar o todo a partir de sua competência.

> Comentário das situações: 1 - B, acolher e discutir com o prescritor, sem orientar ajuste de dose; 2 - B, integrar fontes; 3 - B, respeitar competências; 4 - B, encaminhar pode qualificar o cuidado; 5 - C, a porta de entrada depende da necessidade e da organização da rede; 6 - B, integrar dados e contexto; 7 - B, compreender e colaborar dentro do escopo; 8 - B, considerar as dimensões da pessoa sem dividi-la entre profissões. São explicações educativas, sem pontuação, certificado ou avaliação de saúde do visitante.

- Qual é a hipótese neste momento?

- Que outras possibilidades foram consideradas?

- Há algo clínico que vale investigar?

- Os profissionais que me atendem precisam conversar entre si?

Participar do próprio cuidado não é se autodiagnosticar. É poder perguntar.

CAPÍTULO 10

O que vem pela frente

A Psicologia precisa crescer sem ficar irreconhecível. Mais espaço profissional exige mais clareza pública sobre ciência, avaliação, diagnóstico, trabalho em rede, limites éticos e responsabilidade social.

Eixo	Proposta editorial
Ciência pública	Comunicar evidências sem virar jargão nem conteúdo raso.
Identidade profissional	Mostrar que Psicologia não se resume à psicoterapia.
Avaliação	Valorizar instrumentos e raciocínio clínico sem transformar teste em fetiche.
Rede	Melhorar comunicação entre Psicologia, Medicina, Serviço Social e demais áreas.
Trabalho	Tornar visível o tempo técnico, condições de exercício e debate das 30 horas.

O corpo não termina onde começa a mente. A mente não termina onde começa a sociedade. E nenhuma profissão precisa diminuir a outra para enxergar melhor um ser humano.

Gabriel Batista - texto da edição original

> Conteúdo educativo para compreender profissões e formular perguntas sobre o cuidado. Casos e situações não permitem diagnóstico individual; decisões de avaliação e tratamento dependem do contexto de cada pessoa.

FONTES PARA APROFUNDAR

Referências da edição.

BRASIL. Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962. Regulamentação da profissão de psicólogo.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l4119.htm

BRASIL. Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993. Profissão de assistente social.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8662.htm

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução nº 287, de 8 de outubro de 1998. Categorias profissionais de saúde.

https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/resolucoes/1998/resolucao-no-287.pdf

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Resolução CNE/CES nº 1, de 11 de outubro de 2023. DCNs de Psicologia. DOU, 23 out. 2023, seção 1, p. 55.

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/servlet/INPDFViewer?captchafield=firstAccess&data=23%2F10%2F2023&jornal=515&pagina=55

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolução nº 6/2019 comentada: documentos escritos.

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CFP-n-06-2019-comentada.pdf

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Neuropsicologia: ciência e profissão. Brasília: CFP, 2023.

https://site.cfp.org.br/publicacao/manual-neuropsicologia-ciencia-e-profissao/

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) no CRAS/SUAS. 3. ed. Brasília: CFP, 2021.

https://crepop.cfp.org.br/wp-content/uploads/sites/34/2022/10/028-Crepop-Referencias-Tecnicas-para-atuacao-de-psicologasos-no-CRAS-SUAS.pdf

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Clínica ampliada, equipe de referência e projeto terapêutico singular. 2. ed. Brasília: MS, 2008.

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_equipe_projeto_2ed.pdf

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. Guidelines for Psychologists' Involvement in Pharmacological Issues. Aprovado em agosto de 2025.

https://www.apa.org/about/policy/guidelines-pharmacological-issues.pdf

NEW MEXICO BOARD OF PSYCHOLOGIST EXAMINERS. Steps for a conditional prescribing psychologist to apply for an unrestricted license. 2026.

https://www.rld.nm.gov/wp-content/uploads/2026/05/Steps-for-Unrestricted-Prescribing-Psychologist-License-and-Forms.pdf

CFESS. Parâmetros para atuação de assistentes sociais na Política de Assistência Social. Brasília: CFESS, 2011.

https://www.cfess.org.br/arquivos/Cartilha_CFESS_Final_Grafica.pdf

BRASIL. Senado Federal. PL 1.214/2019: duração do trabalho do psicólogo.

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/175233

BRASIL. Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013. Exercício da Medicina.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12842.htm

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Registro de especialista.

https://site.cfp.org.br/servicos/titulo-de-especialista/

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. SATEPSI: perguntas frequentes sobre avaliação psicológica.

https://satepsi.cfp.org.br/faq.cfm

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Código de Ética Profissional do Psicólogo. Resolução 10/2005.

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo_etica.pdf

NICE. Depression in adults: treatment and management. NG222. Recomendações 1.2.6-1.2.7.2022.

https://www.nice.org.uk/guidance/ng222/chapter/Recommendations

NHS. Antidepressants: side effects.

https://www.nhs.uk/medicines/antidepressants/

Continue a conexão.

Abrir esta edição no site da NEXO

Texto e curadoria de Gabriel Alves Batista